Region Uppsala

AKADEMISKA SJUKHUSET

DOPS
Direct Observational Procedure

ST-läkare

Observatör & Befattning

Verksamhet & Sektion

Nuvarande fas i
☐ ST eller ☐ Placering

BÖRJAN | MITTEN | SLUTET

Observationsområde ☐ Mottagning ☐ Operation ☐ Avdelning ☐ Fri Text

Datum

Utfört ingrepp

Självreflektion

Upplevd svårighetsgrad ☐ Lätt ☐ Ordinärt ☐ Komplext

Styrkor

Kunskaper/färdigheter/förhållningssätt som kan förbättras

Lärdomar

Egna förslag för att uppnå förbättring

Återkoppling från observatör

Svårighetsgrad enligt observatör ☐ Lätt ☐ Ordinärt ☐ Komplext

Styrkor

Kunskaper/färdigheter/förhållningssätt som kan förbättras

Tillvägagångsätt för att uppnå förbättring

Delmoment – Skattning av självständighet

	Skattnignsskala*				Ej Relevant
Innan utförande					
1. Beskriver indikation inklusive risk/nyttavärdering	☐	☐	☐	☐	☐
2. Beskriver teknik/tillvägagångssätt	☐	☐	☐	☐	☐
3. Beskriver anatomi/besitter teoretisk kunskap	☐	☐	☐	☐	☐
4. Förbereder och planerar resurser/material	☐	☐	☐	☐	☐
Under utförande					
1. Utför ingrepp enligt protokoll	☐	☐	☐	☐	☐
2. Förutser och hanterar problem under utförandet	☐	☐	☐	☐	☐
3. Teknisk skicklighet	☐	☐	☐	☐	☐
4. Utnyttjar utrustning adekvat	☐	☐	☐	☐	☐
5. Har bra samspel/kommunikation med kollegor	☐	☐	☐	☐	☐
6. Har bra samspel/kommunikation med patient	☐	☐	☐	☐	☐
7. Följer gällande hygienregler	☐	☐	☐	☐	☐
Efter utförande					
8. Utför relevant dokumentation	☐	☐	☐	☐	☐
9. Ger adekvata instruktioner för vidare vård	☐	☐	☐	☐	☐



DOPS Instruktioner

Beskrivning

En Direct Observational Procedure är en observation av ett ingrepp eller en analys, samt skattning av självständighet i utförande. En DOPS kan användas för att skatta delar av ett ingrepp eller analys, eller hela ingreppet från start till slut.

Observatör och befattning

Observationerna ska utföras flertal gånger och av olika observatörer. Ju fler observationer som görs, samt av olika kollegor, desto mer tillförlitligt blir resultatet. Fler observationer innebär också mer och varierad återkoppling till ST-läkaren, vilket är positivt ur ett pedagogiskt perspektiv. Befattning (specialist eller överläkare) ska inkluderas för att säkerställa att ST-läkaren observeras av seniora kollegor med olika grad av erfarenhet.

Verksamhet & Sektion

Vid ST-läkarens egna och randande specialistområden finns det ofta olika verksamheter (eller ämnesområden) och ibland även specifika sektioner. Om detta finns så ska det specificeras som t.ex. följande

Verksamhet	Övre bukkirurgi	Mikrokirurgi	Lungmedicin
Sektion	Lever-Galla-Pankreas	Bröstrekonstruktion	Astma

Nuvarande fas i ST eller Placering

Beroende på hur ST-läkarens ST-utbildning är upplagd vid enskild klinik, så kryssas rutan som bäst beskriver vart ST-läkaren befinner sig i relation till planerad erfarenhet av den specifika verksamheten i vilken observationen sker. Planeras observationen som återkommande under hela ST-utbildningen så kryssas ”ST”. Är observationen en del i en specifik placering inom verksamheten eller sidotjänstgöring så är det ofta att man endast har möjligheten till att utföra observationen under en specifik tidsram, och man kryssar då i ”Placering” för att inte förväxla fas i ST, med självständighetsgrad i en specifik placering eller randning som ofta sker oberoende av varandra.

Utfört ingrepp

En kort mening som ger en snabb och tydlig bild av vad som observerats.

Exempel

- Insättning av CVK
- Utförande av Mini-mental state examination (MMSE)
- Analys av cytologisk provtagning
- Inställning av mikroskop
- Hudsparande mastektomi

Självskattning

Här ska ST-läkaren ge sin bild av hur man har presterat i observationen. Delmomenten finns som stöd som diskussionsunderlag.

Upplevd svårighetsgrad av fall

ST-läkaren ska göra en skattning av komplexitet-graden av utgångspunkten för observationen

Styrkor

Här ska ST-läkaren specificera styrkor i sitt utförande

Kunskaper/färdigheter/förhållningssätt som kan förbättras

Här ska ST-läkaren ge en kort beskrivning, helst i punktform, av specifika aspekter i utförandet som man själv tycker ska utvecklas

Lärdomar

Här ska ST-läkaren presentera specifika punkter som man har lärt sig från sin egna reflektion och diskussion med observatör.

Egna förslag för till att uppnå förbättring

Här ska ST-läkaren ge en kort beskrivning, helst i punktform av hur man ska uppnå förbättring. T.ex. läsa igenom regelverk/riktlinjer, gå en kurs, läsa på anatomi, simuleringsträna ingreppet

Återkoppling från observatör

Här ska observatören ge sin bild av hur man har presterat i observationen. Delmomenten finns som stöd som diskussionsunderlag.

Svårighetsgrad av fall

Observatören ska göra en skattning av komplexitet-graden av utgångspunkten för observationen

Styrkor

Här ska observatören presentera specifika punkter som framförts bra t.ex. hur presentationen av fallet getts och hur det kliniska omdömet och resonemanget resulterat i hur man slutligen resonerat.

Kunskaper/färdigheter/förhållningssätt som kan förbättras

Här ska observatören ge en kort beskrivning, helst i punktform, av specifika aspekter i resonemanget som man bör utvecklas.

Tillvägagångssätt för att uppnå förbättring

Här ska observatören ge en kort beskrivning, helst i punktform, av hur ST-läkaren ska uppnå förbättring. T.ex. läsa igenom regelverk/riktlinjer, gå en kurs, läsa på anatomi, simuleringsträna ingreppet

Delmoment – förklarande text

Om delmoment är relevant för observationen så ska observatören göra en skattning. Om ej relevant så ska man kryssa i ”Ej relevant”. Skattningen av delmoment ska göras enligt skalan av milstolpar och graderas från behovet av vägledning som ST-läkaren behöver i sitt resonerande eller framlägg av fall och klinisk information.

Innan ingreppet

Beskriver indikation inklusive risk/nyttavärdering

Beskriver relevant bakgrund som lett till beslutet om det specifika ingreppet och risk vs benefit. Ett resonemang kring alternativa tillvägagångssätt är fördelaktigt

Beskriver teknik/tillvägagångssätt

ST-läkaren kan beskriva stegen i ingreppet eller i analysen enligt protokoll

Beskriver anatomi/Besitter teoretisk kunskap

Här skattas ST-läkarens underliggande teoretiska kunskap relevant till ingreppet eller analysen som utförs

Förbereder och planerar resurser/material

ST-läkarens självständighet i att planera inför sitt ingrepp skattas. Detta kan innefatta t.ex. göra upp körschema inför samoperation, planera inför ett inkommande fryssnitt, förbereda bedövning/instrument etc

Under ingreppet

Utför ingreppet enligt protokoll

Här skattas ST-läkarens självständighet i att utföra alla väsentliga steg som krävs för att slutföra ingreppet i ett okomplicerat förlopp. Det är en övergripande skattning som inte detaljerat beskriver alla steg. För ett särskilt index-ingrepp hänvisas man till att utföra en PBA.

Förutser och hanterar problem under utförandet

Här skattas ST-läkarens förmåga att självständigt hantera komplikationer eller svårigheter som uppstår under ingreppet.

Teknisk skicklighet

Här skattas ST-läkarens skicklighet i aspekter som vävnadshantering och instrumenthantering.

Utnyttjar utrustning adekvat

Man kan i detta delmoment skatta skicklighet i hantering av apparatur/kirurgiska eller medicinska redskap

Har bra samspel/kommunikation med kollegor

Här skattas ST-läkarens förmåga att leda och samspela med sin omgivning under ingreppet. Tydlig och ändamålsenlig kommunikation skattas högt, likaså ett engagemang i att involvera sin omgivning i ingreppet genom att dela med sig av kunskap i de steg som utförs.

Har bra samspel/kommunikation med patient

Här skattas ST-läkarens förmåga att kommunicera med sin patient

Följer gällande hygienregler

ST-läkarens förmåga att utföra ingreppet under sterila förhållanden på rätt sätt

Efter ingreppet

Utför relevant dokumentation
ST-läkarens förmåga i att utföra all dokumentation som krävs

Ger adekvata instruktioner för vidare vård
ST-läkarens förmåga i att utforma och ge tydliga och ändamålsenliga post-operativa (eller post-analys) instruktioner till patient eller relevanta kollegor

Skattningsskala - Förklarande text

